

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO MULTIDIMENSIONAL DE EVITACIÓN EXPERIENCIAL (MEAQ)

Eje II: Procesos Psicológicos • Perfil Multidimensional de Evitación Experiencial e Inflexibilidad ACT

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario Multidimensional de Evitación Experiencial (MEAQ: 62 reactivos).
Nombre Original (Inglés)	<i>Multidimensional Experiential Avoidance Questionnaire (MEAQ)</i>
Autores Originales	Drs. Wynne Gámez, M. Chmielewski, R. Kotov, C. Ruggero y D. Watson (2011).
Publicación Original	<i>Psychological Assessment</i> , 23(3), 692-713. American Psychological Association.
Adaptaciones al Español	Adaptaciones y validaciones hispanas (Cremades et al., 2021; Garay et al.; Gómez et al.).
Eje Clínico y Constructo	Eje II: Procesos Psicológicos. Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), Rigidez Transdiagnóstica.
Tipo de Instrumento	Autoinforme multidimensional de 62 ítems con escala Likert de 6 puntos (1 a 6).
Población y Rango	Adultos y jóvenes (desde 16 años). Población clínica ambulatoria y de investigación.
Tiempo de Administración	12 a 15 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Uso científico clínico y académico bajo citación formal de la fuente primaria (APA).

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO MULTIDIMENSIONAL DE GÁMEZ ET AL.

El MEAQ representa el desarrollo psicométrico más completo y riguroso para la conceptualización de la **evitación experiencial (EE)** en el contexto de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT; Hayes et al., 2006). Surgió específicamente para superar las severas críticas dirigidas al AAQ-II, instrumento ampliamente cuestionado por su unidimensionalidad artificial y su excesiva colinealidad con el neuroticismo rasgo y el distrés inespecífico.

El modelo de Gámez et al. (2011) demuestra que la evitación experiencial no es un fenómeno unitario simple, sino un constructo de orden superior configurado por 6 dimensiones conductuales, cognitivas y afectivas mutuamente interconectadas:

1. Conductas manifestadas de escape y aislamiento ante situaciones potencialmente aversivas (**Evitación Conductual**).
2. Creencia inflexible de que experimentar dolor o malestar afectivo es inaceptable e intolerable (**Aversión al Malestar**).
3. Postergación de tareas o decisiones importantes para rehuir el esfuerzo o la incomodidad (**Procrastinación**).
4. Esfuerzos deliberados para apartar pensamientos, recuerdos o afectos molestos del foco de atención (**Distracción / Supresión**).
5. Desconexión consciente o minimización defensiva de las vivencias emocionales vulnerables (**Represión / Negación**).
6. Disposición a sostener y tolerar el sufrimiento en pos de metas significativas (**Tolerancia al Malestar**).

Neurobiológicamente, estas facetas traducen un fallo en la conectividad funcional frontolímbica entre la corteza prefrontal ventromedial/dorsolateral y la amígdala, junto con una deficiente integración interoceptiva insular.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN FACTORIAL DE ÍTEMS

Dimensión Subescala	Nº Ítems	Sentido	Definición Operativa y Foco Clínico Evaluado
1. Evitación Conductual	11 ítems	Directos	Retirada o evitación manifiesta de lugares, tareas o situaciones que causen malestar.
2. Aversión al Malestar	13 ítems	Directos	Actitud de intolerancia y fobia hacia los propios afectos y sensaciones corporales.
3. Procrastinación	7 ítems	Directos	Demora intencional de deberes o metas para eludir la incomodidad inmediata.
4. Distracción / Supresión	11 ítems	Directos	Esfuerzos mentales para desviar la atención o bloquear recuerdos perturbadores.
5. Represión / Negación	9 ítems	Directos	Desafiliación afectiva, alejamiento emocional y negación de la vulnerabilidad personal.
6. Tolerancia Malestar (*)	11 ítems	Inversos	Capacidad de perseverar y sostener emociones dolorosas en pos de valores vitales.

(*) Los 11 ítems de Tolerancia al Malestar se invierten para el cómputo de la evitación experiencial total.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excepcional fiabilidad: alfa de Cronbach de la escala total de 0.93 a 0.94. Consistencia en subescalas: Evitación Conductual (0.87), Aversión al Malestar (0.88), Procrastinación (0.84), Distracción/Supresión (0.85), Represión/Negación (0.83) y Tolerancia al Malestar (0.84). Fiabilidad test-retest $r = 0.82$ a 4 semanas.
Estructura Jerárquica	El Análisis Factorial Confirmatorio ratifica un modelo jerárquico de segundo orden donde un factor macro de Evitación Experiencial engloba las 6 dimensiones de primer orden (CFI = 0.92, TLI = 0.91, RMSEA = 0.052).
Validez Concurrente y Discriminante	Correlaciona positivamente con neuroticismo (NEO-PI-R, $r = 0.54$), depresión (BDI-II, $r = 0.51$) y ansiedad (STAI, $r = 0.56$). Demuestra una validez discriminante netamente superior al AAQ-II al predecir deterioro funcional más allá del afecto negativo.
Sensibilidad al Cambio Clínico	Sensibilidad diagnóstica sobresaliente en protocolos ACT: tras 12 semanas de intervención, los pacientes muestran incrementos marcados en Tolerancia al Malestar junto a caídas pronunciadas en Aversión y Retirada.
Equivalencia Transcultural	Invarianza estructural demostrada entre muestras anglosajonas e hispanoparlantes; las correlaciones entre subescalas replican con exactitud el patrón psicométrico de la validación original de la APA.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 62 reactivos se califica en escala Likert de 6 puntos (**1** = «Totalmente en desacuerdo» a **6** = «Totalmente de acuerdo»):

- **Paso 1 (Inversión Obligatoria de 11 ítems):** Los 11 reactivos pertenecientes a la subescala **Tolerancia al Malestar** deben invertirse: Puntuación = 7 - Respuesta (1 → 6, 2 → 5, 3 → 4, 4 → 3, 5 → 2, 6 → 1).
- **Paso 2 (Puntuaciones por Subescala):** Sumar las puntuaciones de los ítems de cada faceta (con la tolerancia ya invertida si se calcula en sentido de evitación).
- **Paso 3 (Puntuación Total MEAQ):** Suma de los 51 ítems directos más los 11 ítems invertidos de Tolerancia al Malestar.
- **Rango Teórico Global: 62 a 372 puntos.** A mayor puntuación, mayor severidad de la evitación experiencial y rigidez transdiagnóstica.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y PUNTOS DE CORTE (GÁMEZ ET AL., 2011)

Estratificación	Puntuación Total	Nivel de Evitación	Conducta Asistencial Recomendada
Bajo / Flexible	62 a 160 puntos	Aceptación psicológica abierta	Excelente tolerancia a la frustración e incomodidad; acciones guiadas por valores bien preservadas.
Moderado / Medio	161 a 220 puntos	Evitación normativa / Promedio	Conductas evitativas situacionales ante estresores severos; repertorio adaptativo suficiente.
Clínico / Elevado	221 a 275 puntos	Evitación clínicamente significativa (corte ≥ 221)	Inflexibilidad psicológica generalizada. Deterioro funcional en múltiples áreas. Indicación formal de ACT.
Severo / Extremo	276 a 372 puntos	Inflexibilidad invalidante severa	Aislamiento extremo, uso compulsivo de distractores/sustancias y parálisis conductual casi absoluta.

VALOR DIFERENCIAL DEL PERFIL MULTIDIMENSIONAL DE SUBESCALAS:

A diferencia de instrumentos globales breves (AAQ-II o BEAQ), el MEAQ permite cartografiar con precisión quirúrgica el **mecanismo defensivo preferente** del paciente. Dos pacientes con el mismo puntaje total (ej. 240) pueden requerir abordajes radicalmente distintos si uno puntúa en el percentil 95 en Procrastinación (requiriendo activación conductual estructurada) mientras el otro puntúa en el percentil 95 en Aversión al Malestar (requiriendo exposición interoceptiva).

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN EVITACIÓN MULTIDIMENSIONAL (ACT)

PROTOCOLO CLÍNICO MODULAR ACT BASADO EN SUBESCALAS DEL MEAQ:

- **Módulo Aversión al Malestar:** Exposición interoceptiva y disposicional; normalizar el dolor psíquico como señal biológica vital; metáfora de las dos flechas budistas.
- **Módulo Procrastinación:** Tareas graduadas con compromiso de acción pública en valores; fragmentación temporal de metas (técnica de los 5 minutos).
- **Módulo Distracción / Supresión:** Prácticas de mindfulness (MAAS / FFMQ); detener la lucha activa de control de pensamientos (experimento del oso blanco).
- **Módulo Tolerancia al Malestar:** Expansión afectiva experiencial; hacer espacio voluntario a las emociones difíciles mientras se ejecutan conductas valiosas.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN FOBIA SOCIAL Y EVITACIÓN COMPULSIVA

Identificación: Varón de 32 años, programador informático, acude a tratamiento ambulatorio por Trastorno de Ansiedad Social generalizado con consumo diario abusivo de videojuegos y cannabis como mecanismos de desconexión.

Evaluación Inicial MEAQ (Línea Base): Puntuación Total = **288 puntos** (Rango Severo / Extremo). Perfil por subescalas: Aversión al Malestar (72/78), Distracción/Supresión (61/66), Evitación Conductual (58/66), Procrastinación (38/42), Represión (45/54) y Tolerancia al Malestar = 14/66 (tras invertir = 54/66).

Tratamiento Aplicado: Protocolo de 14 sesiones de Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). Se abordó la desesperanza creativa mostrando cómo el refugio virtual en videojuegos ampliaba la soledad real. Se realizaron exposiciones en vivo a eventos sociales con tolerancia compasiva del temblor somático.

Reevaluación a las 14 Semanas: MEAQ Total = **176 puntos** (descenso masivo de 112 puntos, retorno al Rango Moderado / Normativo). Tolerancia al Malestar ascendió a 46/66; Aversión descendió a 32/78; Distracción se redujo a 26/66. El paciente cesó el consumo de cannabis y consolidó una red de amistad presencial.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

REPRESIÓN / NEGACIÓN VS. DISOCIACIÓN:

Puntajes desmesurados en Represión y Negación acompañados de aplanamiento afectivo requieren descartar disociación postraumática (TEPT complejo) o alexitimia severa (TAS-20). No forzar catarsis sin estabilización de recursos de seguridad vincular previa.

SELECCIÓN CLÍNICA: MEAQ VS. BEAQ-15:

En contextos asistenciales con alta saturación temporal, el BEAQ (15 ítems) es la alternativa rápida de cribado. Sin embargo, para la formulación de caso y diseño de intervención modular en psicoterapia de tercera generación, el MEAQ completo es el estándar analítico óptimo.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Gámez, W., Chmielewski, M., Kotov, R., Ruggero, C., & Watson, D. (2011). Development of a measure of experiential avoidance: The Multidimensional Experiential Avoidance Questionnaire. *Psychological Assessment*, 23(3), 692-713.
2. Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. *Behaviour Research and Therapy*, 44(1), 1-25.
3. Cremades, C., Celleri, M., Menéndez, P., & Garay, C. J. (2021). Propiedades psicométricas de la versión argentina del Cuestionario Multidimensional de Evitación Experiencial (MEAQ). *XIII Congreso Internacional UBA*.
4. Gámez, W., et al. (2014). The Brief Experiential Avoidance Questionnaire: Development and initial validation. *Psychological Assessment*, 26(1), 35-45.